示例血脂异常管理指南（2026 版）

mkbAI 演示用合成文本 · 不是任何真实学会的出版物 · 数值为编造，不可用于临床

本文件由项目自带，配合示例高血压指南一起入库。文中阈值、降幅、随访周期均为虚构示例数字。

一、分层与目标值

本示例按动脉粥样硬化性心血管疾病危险分层给出低密度脂蛋白胆固醇的目标值：低危与中危人群低于 3.4 mmol/L，高危人群低于 2.6 mmol/L 且较基线降幅不少于 50%，极高危人群低于 1.8 mmol/L，超高危人群低于 1.4 mmol/L。非高密度脂蛋白胆固醇的目标值为同层低密度脂蛋白胆固醇目标值再加 0.8 mmol/L。

危险分层	低密度脂蛋白胆固醇	非高密度脂蛋白胆固醇
低危 / 中危	低于 3.4 mmol/L	低于 4.2 mmol/L
高危	低于 2.6 mmol/L	低于 3.4 mmol/L
极高危	低于 1.8 mmol/L	低于 2.6 mmol/L
超高危	低于 1.4 mmol/L	低于 2.2 mmol/L

本示例给出的效应量：低密度脂蛋白胆固醇每降低 1 mmol/L，主要不良心血管事件年发生率相对下降约 22%。

二、甘油三酯与低危人群

甘油三酯高于 5.6 mmol/L 时首要处理是降低胰腺炎风险，本示例建议先以贝特类或高纯度鱼油制剂干预，再评估残余心血管风险。甘油三酯在 1.7~5.6 mmol/L 之间者，以非高密度脂蛋白胆固醇作为第二干预靶点。

三、生活方式与复查

饱和脂肪酸供能比控制在 10% 以下，反式脂肪酸尽可能为零，每日膳食纤维 25~30 g，每周中等强度运动 150 分钟。本示例预期降幅：饮食调整 5%~10%、减重 5%~8%、规律运动 3%~5%。

首次用药后 4~6 周复查血脂和转氨酶，达标后每 6~12 个月复查一次。出现肌肉疼痛伴肌酸激酶升高超过基线 5 倍时应暂停并查因。

四、药物选择

起始治疗以他汀类为主，单药不达标者联合依折麦布，仍不达标且属极高危者本示例建议加用前蛋白转化酶枯草溶菌素 9 抑制剂。他汀不耐受者可换用依折麦布单药或联合方案。活动性肝病、妊娠期与哺乳期禁用他汀。